

# Le Psicosi — Sintesi

Salute Mentale · Sessione 09

Sessione densa, ma il filo è chiaro: dalle psicosi organiche alla schizofrenia, sempre con la bussola puntata su cosa significa perdere il contatto con la realtà. Cinque minuti e hai il quadro in testa.

---

## Cos'è la psicosi

- Gruppo eterogeneo di disturbi con **rapporto radicalmente alterato con la realtà**
  - **Caratteristica comune: il soggetto abita un "mondo delirante"** (Pewzner, 2002)
  - **Due destrutturazioni centrali (Jervis):** realtà esterna + identità psicologica interna
- 

## Psicosi organiche vs. funzionali

| Tipo              | Causa                                   | Esempi                                   |
|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Organiche</b>  | Biologica nota e univoca                | Demenze, epilessia, psicosi da sostanze  |
| <b>Funzionali</b> | Multifattoriale (bio + psico + sociale) | Schizofrenia, psicosi maniaco-depressiva |

**Triade io–qui–adesso** (Minkowski): - Demenza → *non sa dove/chi/quando è* (struttura spazio-tempo crollata) - Schizofrenia → *sa dove è, ma non si sente di appartenervi* (distacco interno)

---

# Psicosi organiche — punti chiave

## Demenze

- Indebolimento progressivo e irreversibile di intelletto, affettività, volontà
- **Esempio: Alzheimer** (William Utermöhlen — pittore che ha documentato la propria dissoluzione identitaria con autoritratti)

## Epilessia

- Scarica neuronale abnorme — "attacco a sorpresa"
- **Grande male:** fase tonica → clonica → risolutiva
- **Piccolo male:** assenza di pochi secondi, senza convulsioni — può sembrare distrazione in classe/foyer
- **Crisi parziali:** coinvolgono solo parte del cervello, manifestazione variabile (allucinazioni uditive, movimenti, parestesie)

## Psicosi da sostanze

- Tutte le sostanze psicoattive possono produrre sintomi psicotici (per uso eccessivo o astinenza)
- **Delirium tremens:** psicosi alcolica acuta da astinenza — tremore, allucinazioni, crisi. **Attenzione agli alcolisti che smettono bruscamente**
- **Sindrome di Korsakov:** psicosi alcolica cronica — **amnesia anterograda** (non fissa nuovi ricordi)
- Cannabis indoor: THC elevato → rischio psicotico, specialmente in cervelli in sviluppo

---

## Sintomatologia comune a tutte le psicosi

- **Sintomi positivi** → producono qualcosa che non c'era: **deliri** (contenuto del pensiero) e **allucinazioni** (percezione senza stimolo)
- **Sintomi negativi** → sottraggono: apatia, abulia, ritiro sociale, appiattimento affettivo

- **Disorganizzazione cognitiva** → pensiero frammentato, visibile nel linguaggio
- 

## Schizofrenia

- **Psicosi funzionale per eccellenza**
- Termine di **Bleuler (1911)**: *schizein* (scissione) + *phren* (mente)
- **Il problema non è nell'intelligenza o negli affetti — è nel tenerli insieme**
- **Analogia del prof: orchestra senza direttore. I musicisti ci sono tutti, ma suonano nel caos.**

## Sindrome fondamentale

### 1. Dissociazione (ambito intellettuale, affettivo, psicomotorio)

Disturbi formali del pensiero: - **Disorganizzazione** → pensiero caotico, neologismi, ecolalia - **Impoverimento** → discorso povero, lento, evasivo - **Concretismo** → non accede al simbolico, rimane nel concreto - **Prolissità** → discorso lungo e dispersivo, oscuro - **Tangenzialità** → risponde "di traverso," sfiora il tema senza rispondere - **Deragliamento** → salta da un tema all'altro senza continuità

Disturbi dell'affettività: - **Appiattimento** → reattività emotiva ridotta (ma non assente!) - **Discordanza** → reazione emotiva incongruente con la situazione - **Ambivalenza** → emozioni opposte copresenti

Attività psicomotoria: - Ridotta (la più frequente) → ritiro, apatia, rallentamento - Aumentata → agitazione, **crisi pantoclastica** (spacca oggetti senza finalità) - Qualitativa → manierismi, stereotipie

**2. Autismo** → ritiro nel mondo interno, perdita del senso comune condiviso (oggi: sintomi negativi)

**3. Delirio** → convinzione falsa, incrollabile, palese agli altri. Contenuti: persecuzione, avvelenamento, influenzamento, grandiosità. **Dipende dalla cultura del paziente!**

**4. Depersonalizzazione / Derealizzazione** - Depersonalizzazione → ci si vede dall'esterno, come un automa - Derealizzazione → il mondo è estraneo, c'è una membrana tra sé e la realtà - Tempo "congelato," senza progettualità

**5. Disturbi del comportamento** - **Suicidalità** → rischio 10-20x maggiore della popolazione generale. *Attenzione: il picco è durante il miglioramento, non lo scompenso* - **Alimentazione** → deliri di avvelenamento, evitamento selettivo, pseudo-bulimia - **Sessualità** → autoerotico, angoscia sull'identità sessuale, voci allucinatorie

**6. Allucinazioni** → uditive le più frequenti. Il paziente le vive come reali. Rapporto variabile: le nasconde, le apprezza, vuole tenerle. **Voci perentorie che ordinano azioni** → massima attenzione.

## Angoscia psicotica

- **Angoscia di frammentazione** (diversa da nevrosi: castrazione; borderline: abbandono)
- **Paura di andare a pezzi**
- **Rapporto fusionale con l'altro: i confini tra sé e l'altro sono labili**

---

## Decorso della schizofrenia

| Fase                                     | Caratteristiche                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Premorbosa</b><br>(infanzia)          | Isolamento, ansia sociale, difficoltà relazionali, emotività fredda — leggibile solo retrospettivamente |
| <b>Prodromica</b> (tarda<br>adolescenza) | Stesso quadro accentuato, pensiero strano, neologismi, ritiro progressivo — dura 1-2 anni               |
| <b>Stato</b> (esordio ~20<br>anni)       | Sintomi positivi manifesti, deliri, allucinazioni, scompenso                                            |
| <b>Esiti</b>                             | Remissione / ricadute / stato cronico                                                                   |

**Schizofrenia tipo 1** → sintomi positivi, decorso reversibile **Schizofrenia tipo 2**  
→ sintomi negativi, decorso cronico con deterioramento

**Fattori favorevoli:** diagnosi precoce, buon funzionamento premorbo, sesso femminile, esordio tardivo, rete sociale adeguata, andamento acuto iniziale

**Fattori sfavorevoli:** inizio precoce, familiarità, isolamento, sintomi negativi dominanti

---

## Per l'operatore sociale

- Osservare e comunicare allo psichiatra comportamenti inconsueti (cuffie ad alto volume, cibo evitato, ritiro in camera)
  - **Mai passivizzare il paziente — è ancora una persona con diritti e voce**
  - **Vigilanza *aumentata* quando il paziente migliora (rischio suicidario al picco)**
  - **Valutare il delirio sempre nel contesto culturale del paziente**
- 

**Da ricordare:** - **Io–qui–adesso** (Minkowski): la triade che differenzia psicosi organiche (sgretolate) e funzionali (dissociate) - **Schizofrenia = orchestra senza direttore:** le funzioni ci sono tutte, non riescono a stare insieme - **Il rischio suicidario è più alto nel miglioramento, non nello scompenso**